



• GUIA GRATUITO

Guia de bolso das **Escalas da** **UTI e emergência**

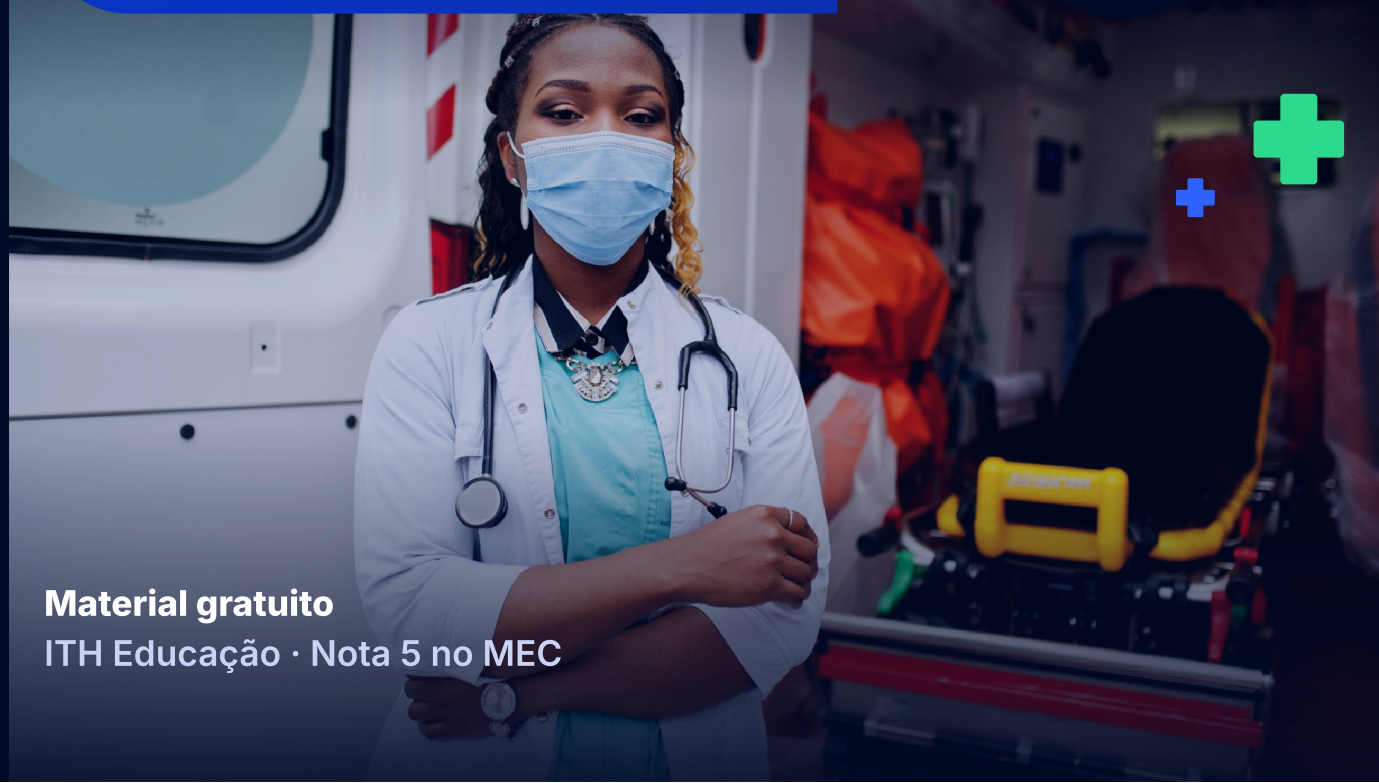
Glasgow, RASS, Braden,
Morse e mais:
**como pontuar e
interpretar**

Com **ficha por
turno** para
imprimir.



Material gratuito

ITH Educação · Nota 5 no MEC



• PARTE 1 • NÍVEL DE CONSCIÊNCIA

Escala de Coma de Glasgow com pupilas

Serve para medir o nível de consciência e, principalmente, acompanhar a **tendência** ao longo do tempo. Aplique na admissão do paciente neurológico ou com trauma e repita conforme o protocolo. A forma atual de avaliar segue a ferramenta oficial do site glasgowcomascale.org.

Componente	O que você observa	Pontos
Abertura ocular (O)	Olhos abertos antes de qualquer estímulo: espontânea	4
	Abre depois de pedido falado ou gritado: ao som	3
	Abre só depois de pressão na ponta do dedo: à pressão	2
	Não abre em momento algum, sem fator que impeça	1
Resposta verbal (V)	Diz corretamente nome, local e data: orientado	5
	Não está orientado, mas conversa de forma coerente: confuso	4
	Palavras soltas e compreensíveis	3
	Apenas gemidos ou sons	2
	Nenhum som audível, sem fator que impeça	1
Melhor resposta motora (M)	Cumprir um pedido de duas etapas: obedece a comandos	6
	Leva a mão acima da clavícula até o estímulo na cabeça ou pescoço: localiza	5
	Dobra o cotovelo rápido, sem padrão anormal: flexão normal	4
	Dobra o cotovelo lento, estereotipado, braço sobre o peito: flexão anormal	3
	Estende o braço no cotovelo: extensão	2
	Nenhum movimento, sem fator que impeça	1

P

Atualização de 2018: GCS-P

Some O + V + M (3 a 15) e subtraia o escore de reatividade pupilar: **0** se as duas pupilas reagem à luz, **1** se uma não reage, **2** se nenhuma reage. **GCS-P = ECG – pupilas**, de 1 a 15. Ajuda a resumir gravidade e prognóstico, sem substituir o registro de cada componente.

≤8

Gravidade no TCE

Pelo Ministério da Saúde: **leve** 13 a 15, **moderado** 9 a 12 e **grave** 3 a 8 pontos. Estímulo físico: pressão na ponta do dedo, pinça do trapézio ou pressão no entalhe supraorbital.

Armadilhas comuns. Componente que não dá para avaliar (paciente intubado, olho fechado por edema, sedação, paralisia) é registrado como **NT, não testável**, nunca como 1. Nesse caso, não informe um total: ele parece pior do que o paciente está. Registre sempre a melhor resposta, compare lados direito e esquerdo e descreva O, V e M separados (ex.: O3 V4 M6), não só a soma.

RASS, Ramsay, Cincinnati e NIHSS

RASS e Ramsay medem o quanto o paciente está sedado ou agitado e guiam o ajuste dos sedativos. Cincinnati e NIHSS servem para suspeitar e graduar o AVC.

RASS (Sessler, 2002)

Pts	Nível e o que você vê
+4	Combativo: violento, risco para a equipe
+3	Muito agitado: puxa tubos ou cateteres, agressivo
+2	Agitado: movimentos sem propósito, briga com o ventilador
+1	Inquieto: ansioso, sem movimentos agressivos
0	Alerta e calmo
-1	Sonolento: acorda à voz e mantém contato visual por mais de 10 s
-2	Sedação leve: acorda à voz, contato visual por menos de 10 s
-3	Sedação moderada: mexe ou abre os olhos à voz, sem contato visual
-4	Sedação profunda: nada à voz, reage ao estímulo físico
-5	Não desperta: nada à voz nem ao estímulo físico

Ramsay (1974)

Pts	Descrição
1	Acordado, ansioso e/ou agitado
2	Acordado, cooperativo, orientado e tranquilo
3	Acordado, só obedece a comandos
4	Dormindo, resposta rápida à percussão glabellar ou som alto
5	Dormindo, resposta lenta a esses estímulos
6	Dormindo, sem resposta

Na versão em português (Nassar Jr., 2008), RASS e SAS tiveram a melhor concordância entre avaliadores.

Como aplicar a RASS: observe primeiro (0 a +4). Se não estiver alerta, chame pelo nome e peça para abrir os olhos e olhar para você (-1 a -3). Só sem resposta à voz use estímulo físico (-4 e -5). A diretriz PADIS 2018 sugere **sedação leve** no paciente em ventilação mecânica; protocolos como o do HC-UFMG/EBSERH usam alvo de **RASS -2 a 0**, salvo indicação médica de sedação profunda.

AVC

Cincinnati (CPSS)

Face: peça para sorrir ou mostrar os dentes; um lado não mexe igual. **Braço:** olhos fechados e braços estendidos; um cai ou não sobe. **Fala:** peça para repetir uma frase; arrastada, palavra errada ou não fala. **Um item alterado já é suspeita:** anote o horário em que foi visto bem pela última vez e acione o protocolo de AVC. No estudo de validação, um item alterado teve sensibilidade de 66% e especificidade de 87%.

NIH

NIHSS em resumo (11 itens)

1a consciência (0-3), 1b perguntas: mês e idade (0-2), 1c comandos (0-2), 2 olhar (0-2), 3 campo visual (0-3), 4 paralisia facial (0-3), 5 braço E e D (0-4 cada), 6 perna E e D (0-4 cada), 7 ataxia (0-2), 8 sensibilidade (0-2), 9 linguagem (0-3), 10 disartria (0-2), 11 extinção ou negligência (0-2). Total de 0 a 42: quanto maior, mais grave. Exige treinamento e o formulário oficial, validado no Brasil.

Armadilhas. RASS e Ramsay não medem dor nem delirium: avalie à parte. Ramsay não gradua bem a agitação, que fica toda no nível 1. Cincinnati normal não descarta AVC, sobretudo de circulação posterior. Na NIHSS, pontue só a primeira tentativa e não ajude o paciente com dicas.



Braden, Morse e qSOFA

As duas primeiras medem risco e orientam a prevenção. O qSOFA é um alerta de mau prognóstico no paciente com suspeita de infecção.

Braden: risco de lesão por pressão (versão validada no Brasil por Paranhos e Santos, 1999)

Subescala (resumo nosso)	O que avalia	Pontos
Percepção sensorial	Capacidade de sentir e comunicar desconforto pela pressão	1 a 4
Umidade	Quanto tempo a pele fica molhada (suor, urina, drenagens)	1 a 4
Atividade	De acamado até anda com frequência	1 a 4
Mobilidade	Capacidade de mudar a posição do corpo sozinho	1 a 4
Nutrição	Padrão habitual de ingestão, jejum, dieta por sonda ou parenteral	1 a 4
Fricção e cisalhamento	Se escorrega na cama e precisa de ajuda para se mover	1 a 3

Total (6 a 23)	Risco	Medida preventiva (Protocolo MS/Anvisa, 2013)
19 a 23	Sem risco	Manter avaliação
15 a 18	Baixo	Cronograma de mudança de decúbito, mobilização, proteção de calcâneos, manejo de umidade e nutrição
13 a 14	Moderado	Tudo acima + decúbito lateral a 30°
10 a 12	Alto	Tudo acima + mudança de decúbito mais frequente e coxins de espuma
≤ 9	Muito alto	Tudo acima + superfície de apoio dinâmico, se possível, e manejo da dor

Morse: risco de queda (versão brasileira, Urbanetto 2013)

Item	Pontuação
Histórico de quedas na internação ou nos últimos 3 meses	Não 0 · Sim 25
Diagnóstico secundário (mais de um diagnóstico médico)	Não 0 · Sim 15
Auxílio na deambulação	Nenhum, acamado ou ajudado pela equipe 0 · Muleta, bengala ou andador 15 · Apoia-se em móveis e paredes 30
Terapia ou dispositivo endovenoso (inclui salinizado)	Não 0 · Sim 20
Marcha	Normal, acamado ou cadeira de rodas 0 · Fraca 10 · Comprometida ou cambaleante 20
Estado mental (pergunte se consegue ir ao banheiro sozinho)	Orientado sobre a própria limitação 0 · Superestima ou esquece limitações 15

Total de 0 a 125: **baixo** 0 a 24, **moderado** 25 a 44, **alto** ≥ 45. Na validação brasileira, o corte de 45 teve sensibilidade de 95,2% e especificidade de 64%.

qSOFA (Sepsis-3, 2016)

Um ponto para cada: **FR ≥ 22/min**, **alteração do nível de consciência** (Glasgow < 15) e **PAS ≤ 100 mmHg**. Com 2 ou mais, o paciente com suspeita de infecção tem maior risco de desfecho ruim e precisa ser investigado para disfunção orgânica.



O que mudou em 2021

A Surviving Sepsis Campaign 2021 recomenda **não usar o qSOFA isolado como ferramenta de triagem** de sepse, comparado a SIRS, NEWS ou MEWS (recomendação forte). Ele é específico, mas pouco sensível: qSOFA negativo não descarta sepse.

Armadilhas. Na Braden, o julgamento clínico é soberano sobre o score e a reavaliação é diária. Na Morse, cateter salinizado conta 20 pontos mesmo sem infusão.

Pontuando um paciente

CÁLCULO RESOLVIDO

Caso fictício: Dona M., 72 anos, internada pela emergência com pneumonia, DPOC e diabetes

Abre os olhos quando é chamada, conversa mas erra a data, obedece a comandos: **Glasgow O3 V4 M6 = 13**

As duas pupilas reagem à luz (pupilas = 0): **GCS-P = 13 - 0 = 13**

Acorda à voz e sustenta o olhar por mais de 10 s: **RASS -1** (sonolenta)

FR 24/min (1) + confusão (1) + PAS 96 mmHg (1): **qSOFA 3**, alto risco de desfecho ruim

Morse: sem queda prévia 0 + diagnóstico secundário 15 + anda com ajuda da equipe 0 + acesso salinizado 20 + marcha fraca 10 + superestima a capacidade 15 = **60, risco alto**

Braden: percepção 3 + umidade 3 + atividade 2 + mobilidade 3 + nutrição 2 + fricção 2 = **15, risco baixo**

Leitura: o qSOFA positivo pede avaliação médica imediata e o protocolo de sepse da instituição. Mesmo com qSOFA 0 ou 1, a suspeita de infecção continuaria sendo investigada. Pela Morse, entram as medidas de prevenção de queda. A Braden de 15 está no limite do baixo risco; com confusão e pouca ingestão, o julgamento clínico pode pedir mais prevenção. Paciente e dados fictícios, criados para fins didáticos.

FERRAMENTA PARA IMPRIMIR

Ficha de escalas por turno

Paciente: _____ Leito: _____ Data: ____/____/____

Escala	Manhã	Tarde	Noite
Glasgow O / V / M (NT se não testável)			
Pupilas reagem? (0, 1 ou 2) · GCS-P			
RASS (alvo prescrito: ____) ou Ramsay			
Braden (total e risco)			
Morse (total e risco)			
qSOFA: FR / PAS / consciência			
Cincinnati: face / braço / fala			
NIHSS (se protocolo de AVC)			
Conduta comunicada / assinatura			

A frequência de cada escala segue o protocolo da sua instituição. Se um escore mudar de faixa entre turnos, comunique a equipe e registre a conduta.



FONTES E METODOLOGIA

De onde vêm as informações

Todas as fontes foram consultadas em 04/10/2026. As descrições dos itens de Braden, Morse, Glasgow e NIHSS foram resumidas com palavras nossas a partir das versões originais e validadas; o caso clínico é fictício e as pontuações foram calculadas pela ITH.

- 01 **Glasgow Coma Scale: ferramenta oficial de avaliação (versão brasileira) e FAQ sobre itens não testáveis**
glasgowcomascale.org/download-aid
- 02 **Brennan, Murray e Teasdale. GCS-P, J Neurosurg 2018;128:1612-1620**
glasgowcomascale.org/what-is-gcs-p
- 03 **Ministério da Saúde. Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa com TCE, 2013**
bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_atencao_reabilitacao_traumatismo_cranioencefalico.pdf
- 04 **Sessler et al. Richmond Agitation-Sedation Scale, Am J Respir Crit Care Med 2002**
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12421743
- 05 **Ramsay et al. Controlled sedation with alphaxalone-alphadolone, BMJ 1974;2:656-659**
europepmc.org/article/PMC/PMC1613102
- 06 **Nassar Jr. et al. Versões em português de Ramsay, RASS, SAS e Glasgow, São Paulo Med J 2008;126(4):215-9**
scielo.br/j/jspmj/a/mp4wKYWf6pf8TbqMbGmSH6j
- 07 **Devlin et al. Diretriz PADIS 2018, Crit Care Med**
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30113379
- 08 **HC-UFMG/EBSEERH. Protocolo 163: analgesia, delírium e sedação em UTI adulto**
gov.br/hubrasil (protocolos assistenciais HC-UFMG)
- 09 **Paranhos e Santos. Escala de Braden na língua portuguesa, Rev Esc Enferm USP 1999;33(nº esp):191-206**
repositorio.usp.br/item/001037655
- 10 **Ministério da Saúde, Anvisa e Fiocruz. Protocolo para prevenção de úlcera por pressão, 2013**
proqualis.fiocruz.br
- 11 **Urbanetto et al. Morse Fall Scale: tradução e adaptação, Rev Esc Enferm USP 2013;47(3):569-75**
revistas.usp.br/reeusp/article/view/77996
- 12 **Urbanetto et al. Predição de risco e validade da MFS versão brasileira, Rev Gaúcha Enferm 2016**
scielo.br/j/rgenf/a/cWpHD8mQ6GRXftfJSjTkGbd
- 13 **Kothari et al. Cincinnati Prehospital Stroke Scale, Ann Emerg Med 1999**
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10092713
- 14 **SAMU-DF 192. Protocolos de regulação médica de urgência (avaliação de AVC)**
saude.df.gov.br
- 15 **NINDS. NIH Stroke Scale (formulário e instruções)**
ninds.nih.gov
- 16 **Cincura et al. Validação da NIHSS no Brasil, Cerebrovasc Dis 2009**
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19039215
- 17 **Singer et al. Sepsis-3, JAMA 2016**
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26903338
- 18 **Evans et al. Surviving Sepsis Campaign 2021, Intensive Care Med**
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8486643

Ressalvas. Este guia resume as escalas e não substitui os formulários oficiais, o treinamento específico (como o da NIHSS) nem os protocolos da sua instituição. Braden, NIHSS e outras escalas têm direitos autorais: use na prática a versão adotada pelo seu serviço. Condutas dependem de avaliação clínica e prescrição médica.

• PARA IR ALÉM

Escala é o começo. A decisão é sua.

Pontuar é fácil. O difícil é ler a tendência, perceber a piora antes do número e agir com a equipe. É isso que a pós em Urgência e Emergência + UTI treina na simulação.

Pós-graduação em Urgência e Emergência + UTI

- ✓ Duas pós em uma, com dupla certificação de especialista
- ✓ Simulação realística de APH, trauma, ECG e ventilação mecânica
- ✓ 880h, formato híbrido, turmas em Goiânia e Brasília
- ✓ Diploma reconhecido pelo MEC (ITH, conceito 5)

[Quero conhecer a pós](#)mkt.faculdadeith.com.br/lp/urgencia-emergencia-uti-captura/

Resumo em 30 segundos

8 escalas

de consciência, sedação, AVC, pele, queda e seps

1 a 15

faixa do GCS-P, a Glasgow com pupilas (2018)

-2 a 0

alvo de RASS comum em protocolos de sedação leve

≥ 45

pontos na Morse indicam risco alto de queda